Les soins du développement du nouveau-né prématuré : Effet de l'intervention motrice orale (PIOMI) sur la progression de l'alimentation et la durée du séjour dans le service de néonatologie du CHU-YO

Nom du présentateur : Dr Aïssa DEMBELE

Auteurs et coauteurs : SAWADOGO O; KOUETA F

Affiliations : CHU-YO

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Plus de **40 %** des prématurés qui survivent **= handicap à vie/ troubles de l'apprentissage / troubles de l'oralité/ problèmes de vue ou d'audition** ➡ **soins du développement**
- **Soins spécifiques+ Soins courants** **=** développement plus harmonieux du prématuré
- Stimulation de l'oralité occupe une place importante car une nutrition optimale ➡ **prérequis sortie d'hospitalisation**

Objectif

- Etudier l'efficacité de l'intervention motrice orale du prématuré sur l'amélioration de sa capacité d'alimentation dans le service de néonatologie du CHU-YO du 7 Novembre au 7 Décembre 2024

Matériel et méthode(s)

- **Cadre de l'étude :**Département de pédiatrie du CHU-YO
- **Type d'étude:** Etude expérimentale prospective, randomisée ouverte à deux groupes parallèles
- **Période :**7 Novembre au 7 Décembre 2024
- **Population d'étude**: Nouveau-nés hospitalisés dans le service de néonatologie du CHU-YO

Matériel et méthode(s)

Critères d'inclusions	Critères de non-inclusion	Critères d'exclusion
❖ Prématurés d'âge gestationnel compris entre 29SA et 34SA ❖ Pas de malformation cliniquement décelable ❖ Consentement parental	❖ Les prématurés instables sur le plan physiologique ❖ Présence de malformations ❖ Présence de pathologie pouvant retarder l'alimentation ❖ NNES ayant séjournés dans une autre FS	❖ Tous les nouveau-nés décédés ❖ transférés ❖ Développement d'une complication en cours d'hospitalisation ❖ Absence d'accord parental

Matériel et méthode(s)

Taille de l'échantillon	**30 nouveau-nés prématurés** ont été **randomisés** 15 cas et 15 témoins
Intervention	Médecins
Suivi et recueil des variables étudiés	Données recueillies par :Internes
Instrument de collecte :	Fiche de collecte
Méthode d'intervention: PIOMI (Thérapie de 5minutes en 8 étapes qui se concentre sur les mouvements des lèvres, de la mâchoire et de la langue).	Instruments: Doits gantés Technique: Etirement /enroulement /massage succion non nutritive selon la procédure du PIOMI

Résultats

Age gestationnel moyen à la naissance	Cas: 31,38±0,93 SA Témoins: 30,27±0,86 SA **p=0,019**
Le poids moyen à la naissance	Cas :1322,94g±125,22 Témoins:1120,67g± 126,91 **P=0,041**
SpO2 moyenne à l'admission:	Cas = 91,38% Témoins= 94,40%
Fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température	normal pour l'âge
Type de prématuré	Grands prématurés :74,20 %.(cas 30% Témoins 44,2%)

Résultats

❑ Pathologies associées

Pathologie associe	Fréquence	Pourcentage
Néant	13	43,33%
Infection néonatale	4	13,33%
Maladie des membranes hyalines	6	20%
Souffrance néonatale	4	13,33%
Souffrance néonatale, infection néonatale	2	6,66%
Souffrance néonatale, maladie des membranes hyalines	1	3,33%
Total	30	100

	Type de malade		p valus
	Cas	Témoin	
Phase1			
N	*15*	*15*	
Durée moyenne en jours	*2,07±0,13*	*2,33±0,46*	*0,744*
Ecart type	*0,258*	*0,9*	
Phase2			
N	*15*	*15*	
Durée moyenne en jours	*2,07±0,13*	*2±0*	*0,77*
Ecart type	*0,258*	*0*	
Phase3			
N	*15*	*15*	
Durée moyenne en jours	*2±0*	*2±0*	*1*
Ecart type	*0*	*0*	
Phase4			
N	*15*	*15*	
Durée moyenne en jours	*2±0*	*2±0*	*1*
Ecart type	*0*	*0*	
Phase5			
N	*15*	*15*	
Durée moyenne en jours	*2±0*	*2,13±0,26*	*0,77*
Ecart type	*0*	*0,516*	
Phase6			
N	*12*	*12*	
Durée moyenne en jours	*2±0*	*2,17±0,36*	*0,75*
Ecart type	*0*	*0,718*	

Résultats

❑ Poids Age et nombre de jour à l'autonomie alimentaire

Paramètre à l'autonomie alimentaire	Type de malade		P valus
	Cas	Témoin	
Age gestationnel en jours			
Moyenne	221,81 ±26,48	225,07±5,68	0,093
Ecart-type	52,331	11,228	
Poids en gramme			
Moyenne	1354,67±73,53	1117,00±58,28	**0,041**
Ecart-type	284,78	225,73	
Nombre de jour mis pour atteindre l'autonomie alimentaire			
Moyenne	11,73±0,28	12,67±0,46	0,188
Ecart-type	1,1	1,80	

Résultats

- **Durée** moyenne de séjours

Groupe d'intervention 14,94±4,91jours

Témoins 19,87±4,71 jours

Différence entre les deux groupes:4,93 Jours

P=0,021

- **Mode de sortie**: Tous Guéris

Conclusion

- PIOMI: impact positif sur la progression de l'alimentation et la réduction de la durée d'hospitalisation du prématuré.
- Approche innovante, simple et sûre pour la prise en charge du nouveau-né prématuré s'intégrant dans le cadre des SDD
- Première étude au Burkina Faso
- Base pour des études ultérieures de plus grande envergure avec des échantillons plus importants.

Merci pour votre attention